INSTRUMENTUL 3 / 5

Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III

Dentară, scheletică sau funcțională? De la molari și canini la cefalometrie, cu comparație laterală, o separi în două minute.

Manualul Ortodontului

MODULUL 1

Clasa II: Dentară sau Scheletică?

Aceeași relație molară de Clasa II poate proveni din mai multe motive. Tratamentul depinde de cauză.

> *Relația molară o inițiază, ANB-ul, Wits-ul și profilul stabilesc diagnosticul. Compensația dentară arată dacă overjet-ul ascunde o anomalie reală.*

INTRAORAL

CLASA II DENTARĂ

- Molari și canini de Clasa II; cel mai adesea migrare mezială superioară (pierdere precoce a molarului de lapte, pierdere de spațiu)
- Un overjet mai mare provine din proclinația incisivilor superiori sau diastemă
- Frecventă Clasa II unilaterală; împreună cu devierea liniei mediane

CLASA II SCHELETICĂ

- Relație molară și canină de Clasa II, similară pe ambele părți
- Overjet mare; în subclasa 2, incisivi centrali superiori retroclinați, overjet mic, supraocluzie pronunțată
- Incisivii inferiori sunt proclinați (compensație)

CEFALOMETRIE

CLASA II DENTARĂ

- ANB în limite normale (~2° ± 2)
- Wits aproape de normal
- SNA ~82°, SNB în jur de ~80°
- U1-SN poate crește; IMPA aproape de normal

CLASA II SCHELETICĂ

- ANB peste 4°
- Wits crescut în direcție pozitivă
- SNB scăzut (retrognatism mandibular, cel mai frecvent) și/sau SNA crescut (prognatism maxilar)
- IMPA crescut: incisivii inferiori compensează

FACIAL

CLASA II DENTARĂ

- Profil drept sau ușor convex
- Bărbie normală; buzele se închid relaxat sau doar buza superioară este împinsă înainte

CLASA II SCHELETICĂ

- Profil convex, bărbie retrasă, linie gât–bărbie scurtă
- Mentalis tensionat la închiderea buzelor; buza inferioară poate ajunge în spatele incisivilor superiori

Testul ocluziei de construcție

Cere pacientului să aducă mandibula înainte până la o relație canină de Clasa I și privește din profil. Dacă profilul se îmbunătățește vizibil, problema ține în principal de mandibulă; la pacienții în creștere se ia în considerare un aparat funcțional (Twin Block, Herbst). Dacă se înrăutățește (bărbia iese în față), problema este maxilară sau dentară.

MODULUL 2

Clasa III: Dentară, Scheletică sau Pseudo?

La Clasa III există și o a treia posibilitate: Clasa III pseudo cauzată de alunecarea funcțională anterioară. Exclude-o mai întâi pe aceasta.

INTRAORAL

CLASA III DENTARĂ

- Molar de Clasa III sau Clasa I; ocluzie inversă frontală la unul sau câțiva dinți
- Incisivi superiori retroclinați, incisivi inferiori proclinați (aceasta este însăși cauza)
- Fără anomalie scheletică între arcade

CLASA III SCHELETICĂ

- Relație molară și canină de Clasa III, similară pe ambele părți
- Overjet negativ sau ocluzie cap la cap; frecvent ocluzie inversă posterioară
- Incisivi superiori proclinați, incisivi inferiori retroclinați (compensație)

CEFALOMETRIE

CLASA III DENTARĂ

- ANB în limite normale
- Wits aproape de normal
- SNA și SNB aproape de normal
- Înclinația incisivilor este sursa problemei

CLASA III SCHELETICĂ

- ANB 0° sau negativ
- Wits crescut în direcție negativă
- SNA scăzut (retruzie maxilară) și/sau SNB crescut (prognatism mandibular)
- IMPA scăzut: incisivii inferiori sunt înclinați spre posterior

FACIAL

CLASA III DENTARĂ

- Profil drept; etaj mijlociu plin
- Bărbie echilibrată

CLASA III SCHELETICĂ

- Profil concav; etaj mijlociu plat sau înfundat, bărbie accentuată
- Buza inferioară înaintea celei superioare; agregare familială frecventă

Diferențierea Clasei III pseudo: testul relației centrice

CLASA III PSEUDO (FUNCȚIONALĂ)	CLASA III SCHELETICĂ ADEVĂRATĂ
• În relație centrică, incisivii pot fi aduși cap la cap • Contact frontal prematur în momentul închiderii, apoi mandibula alunecă înainte • În relație centrică, relația molară este aproape de Clasa I • În relație centrică, profilul se îmbunătățește • Incisivi superiori retroclinați, incisivi inferiori normali sau ușor proclinați	• Overjetul negativ se menține și în relație centrică • Nu există sau este minimă alunecarea; relația centrică și ocluzia uzuală sunt identice • Molari în Clasa III în ambele poziții • Profil concav în ambele poziții • Compensare dentară accentuată

1. **Relaxează pacientul** – așază-l drept, cu capul drept; cere-i să relaxeze mușchii mandibulari.
2. **Ghidează mandibula** – la nivelul mentonului, direcționează fin în spate și în sus; nu forța.
3. **Urmărește primul contact** – se produce pe incisivi? Ajung cap la cap?
4. **Măsoară alunecarea** – notează cât alunecă anterior mandibula de la primul contact până la ocluzia completă.
5. **Compară profilul în două poziții** – profilul lateral în relație centrică și în ocluzie uzuală.

Eroare frecventă

Diagnosticarea unei clasei III scheletice pe baza cefalometriei efectuate în ocluzie uzuală. În cazul alunecării funcționale, mandibula pare mai avansată, ANB-ul este mai slab decât cel real. Înregistrează alunecarea clinic și adaptează evaluarea în consecință.

La pacientul în creștere

În cazul unei a treia clase precoce cu retruzie maxilară, masca facială – împreună cu RME, dacă este necesar – începută la timp are sens. În prognația mandibulară, este necesară monitorizarea până la finalul creșterii și discutarea chirurgiei ortognatice.

MODULUL 3

Tabel Sinoptic: Printează-l, Afișează-l

Scrie valorile pacientului în ultima coloană. Pornește de unde se află majoritatea.

CRITERIU	CLASA II DENTARĂ	CLASA II SCHELETICĂ	CLASA III DENTARĂ	CLASA III SCHELETICĂ	PSEUDO CLASA III	PACIENT
Molar / canin	Clasa II, adesea unilaterală	Clasa II, bilaterală	Clasa I–III	Clasa III, bilaterală	Aproape Clasa I în centrică	
Overjet	Mărit (incisivi)	Mărit (mic în div. 2)	Câțiva dinți frontali în ocluzie inversă	Negativ / cap la cap	Cap la cap în centrică	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	~normal în centrică	
Wits	Aproape de normal	Pozitiv, mărit	Aproape de normal	Negativ, mărit	~normal în centrică	
SNA / SNB	~82° / ~80°	SNB scăzut și/sau SNA crescut	Aproape de normal	SNA scăzut și/sau SNB crescut	Aproape de normal	
Profil	Drept sau ușor convex	Convex, bărbie retrasă	Drept	Concav	Se îmbunătățește în centrică	
Incisiv superior	Proclinație	Protruziv (div. 1), retroclinat (div. 2)	Retroclinat	Proclinație (compensare)	Retroclinat	
Incisiv inferior (IMPA)	~90°	Mărit (compensare)	Proclinație	Scăzut (compensare)	Normal / ușor mărit	
Testul de ocluzie	Profilul se înrăutățește la propulsie	Profilul se îmbunătățește la propulsie	Fără alunecare	Fără alunecare	Cap la cap în centrică	

CRITERIU	CLASA II DENTARĂ	CLASA II SCHELETICĂ	CLASA III DENTARĂ	CLASA III SCHELETICĂ	PSEUDO CLASA III	PACIENT
Prima intenție	Mecanică dentară, gestionarea spațiului	Aparat funcțional la pacientul în creștere; ulterior camuflaj sau intervenție chirurgicală	Corectarea înclinației incisivilor	Mască facială la pacientul în creștere; ulterior camuflaj sau intervenție chirurgicală	Corectarea precoce a ocluziei inverse frontale	

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

După stabilirea diagnosticului, deschide capitolul **Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III**. La pacientul în creștere, consultă cazul similar din **Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială** (10 cazuri), apoi consemnează planul în paginile din **Planificator Clinic în 4 Etape**.